EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 70015
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-08-30 13:09:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ANDRES ANTONIO JELDRES GUERRERO			RUN	: 3.997.967-5
F.Nac	: 25-01-1937	Edad	: 86 AÑOS, 7 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: PARCELA D AGUA BUENA fono 83260149			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 91506361		
Fecha Ingreso	: 2023-08-25	Fecha Egreso	: 2023-08-30 13:09:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

EPOC REAGUDIZADO SOBREINFECTADO
DEMENCIA TIPO ALZHEIMER
HTA
CA PROSTATA EN CONTROL
ACV ANTIGUO SECUELADO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE CON ANTEC DE EPOC, DEMENCIA TIPO ALZHEIMER, HTA, CA PROSTATA EN CONTROL , ACV ANTIGUO SECUELADO, OBS CARCINOMA OREJA IZQUIERDA //AQ: NO REFIERE // ALERGIA MEDICAMENTOS NO REFIERE PACIENTE INSTITUCIONALIZADO, VIUDO. TRABAJÓ EN MINERIA
QUE EL 23/08/23 ES TRAIDO A S.U. HSC POR PRESENTAR CEG PROGRESIVO, EXACERBACIÓN DE LA TOS Y DESATURACIÓN EN DOMICILIO. INGRESA DESATURANDO 88%, AFEBRIL. SE LE TOMAN EXAMENES ENTRE LOS QUE DESTACAN GLICEMIA 149, CREAT 1,0, CL CREAT 70,9, F. ALCALINA 76, BILI TOTAL 0,9, BILI DIRECTA 0,50, SGOT 39, SGPT 38, GGT 99, PCR 83,5, UREMIA 54, NA 137, K 4,1, CL 100, RCTO GLOBULAR GB 14000 C/SEG 88%, HCTO 37,9, HB 12,4, PLAQUETAS 208000, INR 1,32, PT 67%, PT 17,1 SEG,, GSA PH 7,37, PCO2 48, PO2 62,1, HCO3 28,1, BE 2,4, SO2 89 C/FIO2 21%, POR LO QUE SE HOSPITALIZA.
INICIO TTO ATB CEFTRIAXONA, MAS CORTICIDES, INHALOTERAPIA Y KINESITERAPIA, ADEMAS SNG PARA ALIMENTACION. AL 3ER DIA SIN REQUERIMIENTO DE O2, Y SE RETIRA SNG POR BUENA TOLERANCIA VIA ORAL, PACIENTE EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE, CON TOS EN DISMINUCION, PERO CON REQUERIMIENTO DE MANEJO DE SECRESIONES. COMPLETA 7 DIAS DE ATB, SIN DISNEA BUENAS CONDICIONES GENERALES, EXAM PARAMETROS EN RANGO, PERO SE REQUIERE AUN MANEJO DE KINE. POR ELLO SE EGRESA A HODOM.

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO SEMISENTADO, PREVENCION UPP, CONTENCION FISICA SOS
2. REGIMEN HIPOSODICO BLANDO O PAPILLA MAS AGUA
3. PARACETAMOL 500MG 2 C/8 HRS SOS SI DOLOR O FIEBRE
4. SALBUTAMOL 2 PUFF C/6 HRS POR 10 DIAS
5. BR IPRATROPIO 2 PUFF C/6 HRS POR 10 DIAS
6. BREXOTIDE 2 PUFF C/12 HRS POR 10 DIAS
7. TRATAMIENTOS CRONICOS HABITUALES: RETOMAR
8. KINE RESP Y MOTORA 2 VECES AL DIA

9. CONTROL POST ALTA, POLI MED INT 30 DIAS
10. CONTROL SOS URGENCIAS
11. CONTROLES CRONICOS POR APS

EXÁMENES Y RESULTADOS

MEDICAMENTOS HABITUALES:
LACTULOSA 15 CC/DIA, OMEPRAZOL 20 MG 1 COMPRIMIDO/DIA, LOSARTAN 50 MG ½ COMPRIMIDO/DIA, ASPIRINA 100 MG 1 COMPRIMIDO/DIA, SERTRALINA 50 MG 1 COMPRIMIDO/DIA, QUETIAPINA 100 MG 1 COMPRIMIDO/DIA, SALBUTAMOL INH 2 PUFF C/12 HORAS, BUDESONIDA INH 2 PUFF C/12 HORAS, B. IPRATROPIO INH 2 PUFF C/8 HORAS, TAMSULOSINA 0,4 MG 1 COMPRIMIDO/DIA, TRIMEBUTINO 100 MG 1 COMPRIMIDO/DIA.

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO